

Cas clinique 1

Patiente âgée de 39 ans aux antécédents de diabète et ayant une constipation chronique avec des accès de douleurs abdominales spontanément résolutive, qui consulte en urgence pour l'apparition de façon brutale d'une douleur abdominale intense, d'emblée diffuse avec un arrêt franc des matières et des gaz.

À l'examen clinique : la patiente est très algique et agitée, on retrouve un météorisme volumineux, asymétrique prédominant sur le côté gauche, et douloureux. Il est immobile, sans ondulations péristaltiques avec du sang au TR

Vous demandez une TDM abdominale injectée :



1. Selon la présentation clinique et l'aspect à la TDM ; le diagnostic le plus probable est :

- A. Une bride lâche
- B. Une carcinose péritonéale
- C. Une tumeur du colon sigmoïde ulcéro-bourgeonante
- D. Un volvulus du colon pelvien
- E. Une hernie interne para-duodénale

2. Les critères de gravité de l'occlusion chez cette patiente sont :

- A. Le sexe féminin
- B. L'âge jeune de la patiente
- C. La présence de sang au TR
- D. Le mécanisme par obstruction
- E. L'étiologie de l'occlusion

3. Votre conduite à tenir comporte

- A. Une sonde nasogastrique, une sonde vésicale et temporisation
- B. Coloscopie après préparation colique
- C. Un traitement endoscopique en urgence
- D. Une chirurgie en urgence
- E. Une chirurgie à froids après coloscopie et biopsie

Cas clinique 2

Patiente âgée de 61 ans diabétique hypertendu qui consulte pour des douleurs abdominales avec nausée et arrêt des matières et des gaz qui évoluent depuis 4 jours. Par ailleurs elle rapporte la notion de constipation récente remontant à 4 mois non explorée.

A l'examen : patiente calme, stable sur le plan hémodynamique, abdomen distendu en totalité douloureux, le TR montre une ampoule rectale vide ; pas de défense.

A la biologie GB= 15000 élé/mm³, CRP = 70, HB= 9 g/dl, la fonction rénale est correcte

ASP : NHA type colique

Vous demandez une TDM abdominale



4. Le diagnostic le plus probable chez cette patiente est :

- A. Une occlusion sur bride congénitale
- B. Une occlusion sur tumeur du colon sigmoïde avec un caecum pré-perforatif
- C. Une occlusion sur tumeur du colon gauche avec valvule incontinente
- D. Une Occlusion sur tumeur du colon droit
- E. Une occlusion sur iléus biliaire

5. La prise en charge initiale chez cette patiente comporte :

- A. Une sonde nasogastrique en aspiration
- B. Une transfusion d'albumine
- C. Une transfusion de 2 culots globulaire
- D. Un remplissage adéquat
- E. Une colonoscopie avec biopsie

6. La prise en charge chirurgicale chez cette patiente comporte :

- A. Une section de la bride
- B. Colostomie de proche amant car c'est un geste rapide et simple
- C. Une colectomie segmentaire basse avec anastomose colorectale
- D. Une colectomie segmentaire basse avec stomie à la Hartman
- E. Une colectomie subtotale

Cas clinique 3 :

Patient âgé de 55 ans sans antécédent notable consulte pour douleur abdominale avec vomissement et arrêt des matière et des gaz évoluant depuis 48 heures .il rapporte la notion de sang dans les selles depuis 2 mois.

A l'examen : patient calme avec un abdomen distendu tympanique ; TR : ampoule rectale vide.

A la biologie : GB= 9000 élé / mm³, Hb =10 g/dl ; la fonction rénale est correcte

ASP ci-joint :



TDM abdominale : tumeur de la brache descendante du colon sigmoïde en occlusion

7. Les signes de gravité scanographique que vous devrez rechercher chez ce patient sont :

- A. La dilatation du colon transverse en amont de l'obstacle à 8cm
- B. Une pneumatose pariétale
- C. Un défaut de rehaussement pariétale
- D. Un caecum à 7 cm
- E. Un épanchement intrapéritonéal de faible abondance

Aucun signe de gravité scanographique n'a été objectivé

8. Vous décidez d'hospitaliser le malade, votre prise en charge initiale comporte :

- A. Une sonde vésicale avec une sonde nasogastrique
- B. Une prothèse endoscopique
- C. Une sonde rectale en aspiration
- D. Equilibration des troubles hydroélectrolytiques
- E. Une antibiothérapie à large spectre

L'évolution au bout de 24 heure s'est faite vers l'aggravation avec une majoration de la distension abdominale et des vomissements devenant plus fréquent ; la FID est souple, la biologie est sans anomalies.

9. Vous décidez alors :

- A. De réaliser une colostomie de proche amont
- B. De continuer la réanimation
- C. De réaliser une colectomie segmentaire basse avec anastomose colorectale
- D. De réaliser une iléostomie
- E. De réaliser une colo-exsufflation et mise en place d'une deuxième sonde rectale

Cas clinique 4

Patient âgé de 75 ans diabétique hypertendu, opéré pour ulcère perforé par voie médiane il y a 30 ans consulte pour syndrome occlusif évoluant depuis 6 jours. Par ailleurs il rapporte la notion de constipation évoluant depuis 6 mois.

A l'examen ; patient calme, abdomen distendu en totalité, pas de défense ; orifices herniaires libres.

A la biologie : GB= 10000 élé / mm³ ; Hb = 9 g/dl, insuffisance rénale fonctionnelle

ASP : des NHA mixtes

A la TDM abdominale : tumeur de l'angle colique gauche en occlusion, le colon en amont est distendu à 8 cm ,le caecum est non dilaté avec une distension iléale et des NHA de type grêle.

10. Cette occlusion peut être en rapport avec :

- A. Une tumeur de l'angle colique gauche avec valvule continente
- B. Une tumeur de l'angle gauche avec carcinose péritonéale
- C. Une tumeur de l'angle colique gauche avec bride postopératoire
- D. Une tumeur de l'angle colique gauche avec envahissement grêlique
- E. Une tumeur de l'angle colique gauche perforé

11. Chez ce patient vous indiquez

- A. Une colostomie de proche amont
- B. Une mise en place de prothèse endoscopique
- C. Une exploration par voie médiane
- D. Une colo-exsufflation
- E. Une coloproctectomie totale

Cas clinique 5

Patiente âgée de 65 ans, obèse, sédentaire, actuellement à la retraite, aux antécédents de constipation chronique, consulte pour des douleurs abdominale, nausée et un arrêt des matières et des gaz. Par ailleurs elle rapporte la notion de douleur de la fosse iliaque gauche récidivante pour lesquels elle n'a pas consulté.

A l'examen : une patiente calme consciente, température = 37°, TA=120 /80 mm Hg, FC= 88 /min. L'abdomen est distendu dans sa totalité sans défense, et les orifices herniaires sont libres.

Au TR, le doigtier est propre.

A biologie : GB=12000 élé/mm³, CRP : 10mg/l, fonction rénale : correcte.

La TDM montre un épaississement régulier et sténosant de la paroi du colon sigmoïde, avec présence d'images d'addition multiples de la paroi colique sans signe de participation grêlique ni de dilatation significative du caecum.

12. Les diagnostics à évoquer chez cette patiente sont :

1. Un ADK du colon sigmoïde
2. Une sigmoïdite pseudo tumorale
3. Une colite infectieuse
4. Une amibiase intestinale
5. Une RCH

Une réanimation adéquate a été démarré mais au bout de 24 h de surveillance la patiente ne s'améliore pas, vous décidez d'opérer la patiente,

13. Votre stratégie comporte :

1. Une colostomie de proche amant
2. Une colectomie segmentaire basse emportant la charnière recto-sigmoïdienne avec stomie à la Hartman
3. Une colectomie totale
4. Une coloproctectomie totale
5. Une colectomie gauche carcinologique avec rétablissement immédiat de la continuité digestive

Cas clinique 6 :

Patient âgé de 59 ans, aux antécédents de diabète sous insuline, opéré il y a 30 ans pour péritonite appendiculaire par voie médiane, qui consulte pour des douleurs abdominales diffuses d'aggravation progressive associé à quelques épisodes de vomissement et un arrêt des matières et des gaz évoluant depuis 48 h.

L'examen clinique trouve un patient calme, apyrétique avec un météorisme diffus, des orifices herniaires libres et le toucher rectal montre un rectum vide.

Un ASP a été demandé.



14. L'ASP montre :

- A- Des NHA plus large que haut
- B- Des NHA type colique
- C- Une dilatation importante du caecum
- D- Un pneumopéritoine
- E- Un arceau avec double jambage

15. Autre que l'origine tumorale de cette occlusion, vous évoquez :

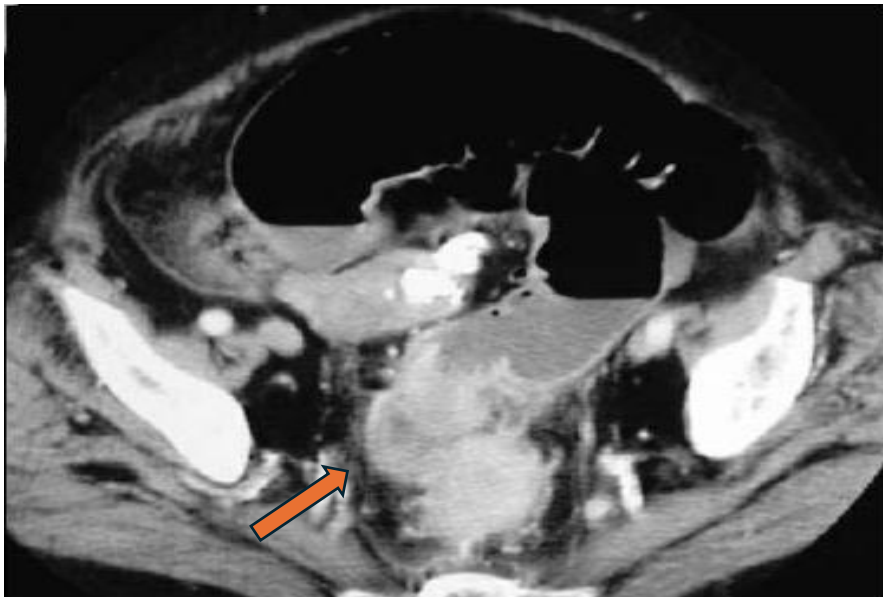
- A- Une sigmoïdite pseudo-tumorale
- B- Un volvulus du colon pelvien
- C- Une amibiase intestinale
- D- Un syndrome d'Ogilvie
- E- Un iléus biliaire

Le malade a été hospitalisé en milieu de réanimation médicochirurgicale les mesures de réanimation ont été entamées ;

16. Parmi ces mesures vous retenez :

- A- Une sonde nasogastrique en siphonage
- B- Une sonde rectale
- C- Une sonde vésicale
- D- Equilibration de son diabète
- E- Double voie d'abord avec remplissage adéquat

Dans le cadre du diagnostic étiologique une TDM a été pratiquée.
Cette TDM montre :



Devant l'absence de signes de gravité, la décision était de continuer le même traitement et de surveiller le malade.

12h plus tard le malade décrit une accentuation des douleurs avec une majoration du météorisme. L'examen montre une défense de la fosse iliaque droite.

17. Vous décidez :

- A- D'opérer le malade car il s'agit probablement d'une valvule iléo-caecale incontinente
- B- D'opérer le malade par voie élective car il y a un risque de perforation diastatique du caecum
- C- Autre que la chirurgie, la mise en place d'une endoprothèse est possible
- D- Autre que la chirurgie, la dévolvulation endoscopique est possible
- E- Il faut opérer le malade par voie médiane

En peropératoire on trouve une tumeur du sommet de la boucle sigmoïdienne avec une distension importante du colon en amont dont le maximum, se situe au niveau du caecum dont la paroi paraît ischémié,

18. On décide alors de réaliser :

- A- Colectomie subtotale avec anastomose iléo-colique.
- B- Une sigmoïdectomie
- C- Une colectomie segmentaire haute
- D- Une colostomie
- E- Hémi-colectomie gauche vraie

Cas clinique n°7 :

Mr A.H âgé de 70 ans aux antécédents de péritonite par ulcère perforé opéré par voie médiane il y a 1 an et de constipation chronique, consulte pour des douleurs abdominales d'installation brutale avec arrêt des matières et des gaz, associé à des nausées. L'examen clinique et les explorations radiologiques étaient en faveur du volvulus du colon pelvien.

19. En faveur de ce diagnostic vous retenir :

- A- Le début brutal
- B- Le météorisme important asymétrique avec un grand axe de la FIG vers l'HCDT
- C- L'absence de péristaltisme
- D- AMG franc
- E- Antécédent de chirurgie

20. Parmi les signes radiologiques à rechercher :

- A- Une aérobilie
- B- Une Image en double jambage à l'ASP
- C- Un pneumopéritoine
- D- Des NHA plus large que haut
- E- Un wirl sign à la TDM

21. Le toucher rectal ramène un doigtier souillé de sang, parmi les options thérapeutiques :

- A- Une dévolvulation endoscopique
- B- Une résection sigmoïdienne avec anastomose si les conditions locales le permettent
- C- Mise en place d'une endoprothèse
- D- Continuer le traitement médical et la réanimation
- E- Une sigmoïdectomie sans rétablissement à la BW si on retrouve une péritonite associée

Cas clinique 8 :

Vous recevez Mr AY âgé de 62 ans hypertendu diabétique qui consulte pour un syndrome occlusif évoluant depuis hier soir, par ailleurs il rapporte la notion d'épisodes de selle noire ainsi qu'une alternance diarrhée constipation évoluant depuis 5 mois. L'examen abdominale trouve un patient calme avec un météorisme abdominale diffus. A la biologie vous trouvez une anémie hypochrome microcytaire à 9 g /dl.

A l'ASP on retrouve des NHA de type colique.

Vous suspectez une occlusion basse probablement sur tumeur colorectale.

22. Quel examen demandez-vous pour ce patient devant ce tableau :

- A. Une rectoscopie avec biopsie
- B. Un lavement baryté
- C. Une TDM abdominale injecté
- D. Une coloscopie totale avec biopsie
- E. Une échographie abdominale avec biopsie

L'examen que vous avez demandé a montré une tumeur de la branche ascendante du colon sigmoïde en occlusion sans aucun signe de gravité.

Le patient a été hospitalisé en unité de réanimation médico-chirurgicale,

23. La réanimation initiale comporte :

- A. Une sonde nasogastrique
- B. Une sonde vésicale
- C. Un remplissage adéquat
- D. Une équilibration hydroélectrolytique
- E. Une sonde rectale

L'évolution est favorable, le patient a rétabli son transit sous forme de débâcle diarrhéique, la douleur a disparu et la distension abdominale a régressé.

24. Le bilan d'extension chez ce malade comporte :

- A. Un scanner thoraco abdomino pelvien
- B. Un scanner cérébral
- C. Un uroscanner
- D. Une cystoscopie
- E. Une coloscopie par le bout de la stomie

Le bilan d'extension que vous avez demandé est négatif.

25. Le geste à réaliser chez ce patient comporte :

- A. Une sigmoïdectomie avec ligature des vaisseaux à ras du colon par voie coelioscopique
- B. Une colectomie totale
- C. Une résection segmentaire basse avec ligature de l'artère mésentérique inférieur après le départ de la colique supérieure gauche
- D. Une coloproctectomie avec anastomose ilio-anale
- E. Une hémicolectomie droite

L'examen histologique de la pièce opératoire montre une tumeur qui envahit la sous-séreuse sans la dépasser avec 2 métastases ganglionnaires dans les 15 ganglions prélevés.

26. La tumeur est classée :

- A. T1N1M1
- B. T1N1M0
- C. T2N1M0
- D. T3N1M0
- E. T3N0M0

27. Le traitement adjuvant que vous indiqué chez ce patient comporte :

- A. Une chimiothérapie devant les métastases ganglionnaires
- B. Une radiothérapie devant la localisation de la tumeur
- C. Une radio-chimiothérapie devant l'envahissement de la sous séreuse
- D. Une curiethérapie
- E. Une abstention thérapeutique

28. Vous suivez ce patient à la consultation externe, durant les 2 premières années, vous lui demandez tous les trois mois :

- A. Une radio thorax
- B. Une coloscopie
- C. Une échographie abdominale
- D. ACE
- E. PSA

Cas clinique 9 :

Vous recevez Mr AM âgé de 80 ans tabagique, hypertendu, diabétique, suivi pour coronaropathie, qui consulte pour des douleurs abdominales diffuse avec vomissement bilieux et un AMG évoluant depuis deux jours, par ailleurs il rapporte la notion de douleur de la fosse iliaque gauche, vagues évoluant depuis 2 mois, il rapporte aussi la notion d'épisodes de rectorragie.

L'examen abdominale trouve un patient calme avec une distension abdominale diffuse et à la biologie vous trouvez une anémie hypochrome microcytaire à 8 g /dl.

Vous demandez une TDM abdominale injecté, elle montre une tumeur de la branche descendante du sigmoïde en occlusion, un épanchement intrapéritonéal de moyenne abondance, sans signe de participation grêlique ni de distension caecale.

29. Parmi les signes suivants quels sont ceux qui signe la gravité du tableau chez ce patient :

- A. Les vomissements bilieux
- B. L'âge
- C. Les comorbidités
- D. La localisation sigmoïdienne de l'obstacle
- E. L'épanchement intrapéritonéale de moyenne abondance

Malgré une réanimation adéquate le patient garde toujours les douleurs abdominales ; le météorisme devient plus important et les vomissements plus fréquents.

30. Autre que la colostomie il est possible de réaliser :

- A. Une résection segmentaire basse avec anastomose colorectale immédiate
- B. Une résection segmentaire basse avec double stomie à la Bouilly-Wolkman
- C. Une sigmoïdectomie
- D. Une hémicolectomie gauche avec anastomose immédiate
- E. Une résection segmentaire basse avec stomie à la Hartman

Le patient a eu une colostomie de proche amant, les suites opératoires sont simples.

Le patient a eu une coloscopie totale avec biopsie concluant à une tumeur sigmoïdienne de 4 cm correspondant à un adénocarcinome lieberkühnien à la biopsie.

31. Le bilan d'extension chez ce malade comporte :

- A. Dosage des ACE et CA 19-9
- B. Un scanner cérébral
- C. Un scanner thoraco abdomino-pelvien
- D. Un uroscanner
- E. Une cystoscopie

Le bilan d'extension que vous avez demandé est négatif.

32. Vous décidez d'opérer le patient, la préparation à la chirurgie comporte :

- A. Des bas de contention pour prévenir le risque thromboembolique
- B. Arrêt du tabac
- C. Transfusion sanguine
- D. Equilibration du diabète
- E. Equilibration du bilan lipidique

33. Le geste à réaliser chez ce patient comporte :

- A. Une hémicolectomie gauche avec ligature des vaisseaux à ras du colon
- B. Une hémicolectomie gauche avec ligature des artères colique gauche à leurs origines
- C. Une colectomie totale devant la taille de la tumeur
- D. Une coloproctectomie avec anastomose ilio-anale devant l'âge du patient
- E. Une résection segmentaire basse

34. L'examen histologique de la pièce opératoire montre une tumeur classée T3N1M0

Ceci correspond à :

- A. Une tumeur qui envahie la sous séreuse sans la dépasser avec métastases ganglionnaire
- B. Une tumeur qui envahie la sous séreuse sans la dépasser sans métastases ganglionnaire
- C. Une tumeur qui atteint la musculuse sans la dépasser avec métastases ganglionnaire
- D. Une tumeur qui envahie la muqueuse colique sans la dépasser avec métastases ganglionnaire
- E. Une tumeur qui envahie le péritoine viscéral avec métastases ganglionnaire

35. Le traitement adjuvant que vous indiquez chez ce patient comporte :

- A. Des immunosuppresseurs
- B. Une chimiothérapie devant l'âge du patient
- C. Une radiothérapie devant les métastases ganglionnaires
- D. Une chimiothérapie devant les métastases ganglionnaires
- E. Une chimiothérapie devant la localisation sigmoïdienne de la tumeur

36. Vous suivez ce patient à la consultation externe, durant les 2 premières années, vous lui demandez :

- F. Une radio thorax tous les trois mois
- G. Une coloscopie à 1 an.
- H. Une échographie abdominale tous les ans
- I. ACE tous les 2ans
- J. PSA tous les trois mois

Cas clinique 10 :

Il s'agit d'un homme de 33 ans au antécédents chirurgicaux d'appendicite opéré il y a 15 ans qui consulte pour douleur abdominale avec vomissement suivi d'un arrêt des matières et des gaz évoluant depuis quelque heure, les douleurs sont d'installation progressive devenant rapidement intense.

A l'examen ; patient apyrétique, très algique et agité

Son abdomen est distendu surtout au niveau de la FID

On retrouve une hernie crurale droite réductible impulsive à la toux et non douloureuse

À la biologie : GB= 12000ele / mm³ CRP = 15, la fonction rénale est correcte.

L'ASP montre des NHA type grêle

Vous réalisez une TDM abdominale



37. Le diagnostic le plus probable est :

- A. Une rectocolite hémorragique
- B. Une bride postopératoire
- C. Une appendicite sur moignon
- D. Une tumeur du colon droit
- E. Une hernie crurale droite étranglée

38. Votre conduite à tenir :

- A. Une section de la bride
- B. Une mise en place d'une sonde nasogastrique et d'attendre le rétablissement spontané du transit
- C. Une colo-exsufflation
- D. Mise en place d'un stent
- E. Une cure de la hernie par raphie

QCM :

39. Les Occlusions sur bride :

- A- peuvent survenir de façon tardive
- B- Sont Surtout rencontrées après chirurgie sus mésocolique
- C- Sont Favorisé par une chirurgie septique
- D- peuvent compromettre la vitalité de l'anse intéressée
- E- Sont la cause la plus fréquente des occlusions intestinales aiguës

40. Une Occlusions intestinale aigüe peut être secondaire à :

- A- Un fécalome
- B- Une tumeur rétropéritonéale
- C- Un calcul biliaire bloqué au niveau de la valvule de Bauhin
- D- Une hernie de spiegel non compliquée
- E- une sigmoïdite pseudo-tumorale

41. Au cours des occlusions fonctionnelles, on retrouve :

- A- Une douleur paroxystique à type de crampes
- B- l'absence Des bruits hydro-aériques à l'auscultation,
- C- Une distension radiologique n'intéressant que le grêle
- D- Un météorisme volumineux,
- E- Une prédominance des images gazeuses à l'ASP

42. Au cours d'un syndrome occlusif la sonde naso-gastrique en aspiration permet de :

- A- réduire la distension abdominale
- B- Éviter une infection
- C- éviter les vomissements
- D- éviter l'inhalation au moment de l'induction anesthésique
- E- suivre l'évolution en appréciant la quantité et la qualité du liquide aspiré.

43. Parmi ces propositions concernant les traitements des occlusion intestinale aiguës, le(s)quelle(s) sont vraie(s) ?

- A- La mise en place d'une endoprothèse est contre indiquée devant des signes de souffrance intestinale
- B- Il est possible de faire une colostomie de proche amont devant une occlusion du colon gauche avec des signes de participation du grêle
- C- On devrait opérer toutes les occlusions du colon gauche en urgence
- D- Une antibiothérapie est systématique
- E- On devrait opérer tout malade présentant une occlusion avec des signes de souffrance intestinale.

44. Concernant Les occlusions par strangulation :

- A- La striction intéresse seulement le méso de l'anse
- B- Peuvent être responsable de lésions graves de nécrose et de perforation
- C- Peuvent être secondaire à l'incarcération d'une anse dans le hiatus de Winslow
- D- Peuvent être secondaire bride péritonéale
- E- Ne Peuvent pas être secondaire au télescopage d'un segment intestinal dans un autre

45. Les occlusions fonctionnelles

- A- Peuvent être secondaire à une Hypokaliémie
- B- Sont en rapport avec une anomalie de contractilité de l'intestin
- C- Peuvent être secondaire à la prise de Blactamine
- D- Peuvent être responsable de lésions graves de nécrose et de perforation
- E- Peuvent être secondaire à une tumeur du grêle

46. Au cours de l'OIA :

- A- La présence d'un seul de ces signes suffit pour évoquer le diagnostic
- B- La présence d'une cicatrice abdominale devrait faire évoquer le diagnostic d'une bride
- C- On peut avoir une contracture à l'examen clinique
- D- La présence de bruits hydroaériques est en faveur de l'occlusion fonctionnelle
- E- Il ne faut pas attendre les 4 signes cardinaux de l'occlusion pour poser le diagnostic positif

47. La dévolvulation endoscopique en cas d'un volvulus du colon pelvien :

- A- Permet de passer le cap aigue
- B- Est proscrite devant un météorisme asymétrique
- C- Est contre indiqué devant des signes d'ischémie
- D- Présente un risque de perforation
- E- Est réalisée sans insufflation

48. Les Occlusions sur bride :

- A- Ne surviennent que de façon tardive
- B- Sont Surtout rencontrées après chirurgie sus mésocolique
- C- Sont Favorisé par une chirurgie septique
- D- Ne peuvent pas compromettre la vitalité de l'anse intéressée
- E- Sont la cause la plus fréquente des occlusions intestinales aiguës

49. Au cours des OIA, les vomissements sont

- A- Tardif en cas d'occlusion haute
- B- Précoce en cas d'occlusion basse
- C- Soulage le malade
- D- Responsable d'une alcalose métabolique par perte du HCL
- E- Peuvent être remplacé par des nausées

50. Au cours des OIA :

- A- Lorsque la valvule iléo-caecale est continente une perforation diastatique du caecum est possible
- B- Lorsque la valvule est forcée, une péritonite stercorale par perforation caecale est possible
- C- La présence de niveau NHA type grêle en cas de tumeur du colon gauche en occlusion traduit une valvule forcé et autorise une colostomie de décharge par voie élective.
- D- La présence d'une défense de la FID devant une tumeur du colon gauche en occlusion impose un accès par vois médiane
- E- La présence de signe de souffrance en cas de volvulus du colon pelvien autorise une exsufflation endoscopique

51. La distension intestinale au cours des OIA :

- A- Est responsable de la stase veineuse pariétale
- B- Est responsable des troubles anoxique locaux de la paroi intestinale
- C- Est secondaire à l'accumulation des gaz et des liquides digestifs
- D- Est responsable de la diminution du retour veineux
- E- Est responsable de l'augmentation du jeu diaphragmatique

52. Parmi les signes de gravité d'une OIA :

- A- Les vomissements répétés
- B- La polypnée
- C- Trouble de conscience
- D- La fièvre
- E- L'épanchement intrapéritonéal

53. Parmi les signes de gravité radiologique d'une OIA :

- A- La présence d'un PNP
- B- Caecum à 7cm
- C- Pneumatose pariétale
- D- Perte de prise de contraste de la paroi abdominale
- E- Anse grêles à 2 cm

54. Les invaginations intestinales aigues :

- A- Sont fréquente chez le sujet âgé
- B- Peuvent survenir sur un diverticule de Meckel
- C- Peuvent survenir Sur une tumeur de la paroi
- D- Peuvent survenir Sur un polype de la paroi
- E- Se voient surtout chez les nourrissons

55. Au cours des OIA :

- A- Phytobézoard ne sont pas favorisé par les antécédents de gastrectomie ou de GEA
- B- Les trichobézoard peuvent se bloqué au niveau de l'iléon terminale
- C- L'iléus biliaire donne une occlusion par à-coup
- D- Les nodules de carcinose peuvent donner une compression extrinsèque
- E- Un hématome intra murale par surdosage en AVK peut être responsable d'une OIA

56. Les cancers coliques en occlusion

- A- Sont fréquent pour le colon droit
- B- Sont responsable d'une occlusion par compression
- C- Ont un début progressif
- D- S'associe à une altération de l'état général
- E- S'associe à une alternance diarrhée constipation récente

57. Parmi les signes de gravité d'une occlusion intestinale aigue :

- A- la fièvre,
- B- la déshydratation,
- C- vomissement bilieux,
- D- d'une hyperleucocytose
- E- météorisme important

58. Parmi les signes de gravité radiologique d'une occlusion intestinale aigue :

- A- La présence d'un rehaussement pariétal,
- B- Une pneumatose pariétale
- C- Diamètre caecal dépassant les 12 cm
- D- L'épanchement intra abdominal
- E- Diamètre colique à 3cm

59. Devant une OIA sur tumeur du colon gauche, La mise en place d'une endoprothèse :

- A- Est possible devant des NHA type grêle
- B- Est possible devant une défense de la FIDte
- C- Est proscrite devant une tumeur du sigmoïde
- D- Permet de passer le cap aigue et d'opérer le malade en de meilleures conditions
- E- Evite une colostomie en urgence

60. Au cours des occlusions par obturation :

- A- Le début est généralement progressif
- B- Le météorisme est animé d'ondulation péristaltique
- C- Les plus fréquentes des occlusions mécaniques
- D- L'état général est souvent conservé
- E- L'occlusion est complète et irréversible

61. Au cours des occlusions par strangulation :

- A- Le début est brutal
- B- L'état général est rapidement altéré
- C- Le météorisme est diffus et important avec ondulations péristaltiques
- D- Les douleurs abdominales survenant par crises et évoluant sur un fond continu
- E- La sédation brusque de la douleur est un bon signe.

62. Les Occlusions fonctionnelles peuvent se voir en cas de:

- A- Appendicites méso-coéliquales
- B- Cholécystites aiguës
- C- Coliques néphrétiques
- D- Un diverticule de Meckel non compliqué
- E- L'hématome rétropéritonéal

63. Une nécrose de l'intestin grêle lors d'une occlusion intestinale aiguë peut se voir en cas de :

- A- Hernie inguinale étranglée
- B- Invagination intestinale aiguë
- C- Péritonite appendiculaire.
- D- Diverticule de Meckel compliqué
- E- Occlusion sur bride.

